

Chuyển Lưu Nước Tiểu — So Sánh Các Lựa Chọn

Thông tin cho bệnh nhân · Ba cách dẫn nước tiểu khi bàng quang bị cắt bỏ hoặc không còn hoạt động

WARWIKI

Khi bàng quang bị cắt bỏ hoặc không còn hoạt động, nước tiểu cần một con đường mới để ra khỏi cơ thể — đây gọi là chuyển lưu nước tiểu. Có ba loại chính. Tất cả đều dùng một đoạn ruột của bạn và khác nhau chủ yếu ở **cách thoát nước tiểu hằng ngày**: túi đeo bên ngoài, tiểu qua niệu đạo, hoặc tháo nước tiểu bằng ống thông. Tờ này so sánh ba lựa chọn; mỗi lựa chọn cũng có tờ hướng dẫn riêng chi tiết hơn.

Ba Lựa Chọn

ĐEO TÚI BÊN NGOÀI

Ống Dẫn Hồi Tràng (Ileal Conduit)

Một đoạn ruột ngắn dẫn nước tiểu ra một lỗ nhỏ (**lỗ mở**) trên bụng, nơi nước tiểu chảy liên tục vào một **túi** nhẹ mà bạn tháo và thay. Đơn giản và phổ biến nhất; không cần kiểm soát hay dùng ống thông.

TIỂU QUA NIỆU ĐẠO · KHÔNG CẦN TÚI

Bàng Quang Mới (Neobladder)

Một túi chứa mới làm từ ruột được nối với **niệu đạo**, cho phép bạn tiểu theo cách tự nhiên mà không cần túi. Bạn tập đi tiểu theo **giờ cố định** (cả ngày lẫn đêm), đôi khi vẫn cần ống thông, và rò rỉ thường gặp lúc đầu.

THÁO BẰNG ỐNG THÔNG · KHÔNG CẦN TÚI

Chuyển Lưu Ra Da Có Kiểm Soát (Indiana Pouch)

Một túi chứa bên trong làm từ ruột giữ nước tiểu, với một lỗ mở kín nhỏ (thường ở **rốn**). Không cần túi — bạn đưa **ống thông** qua lỗ mở để tháo nước tiểu vài lần mỗi ngày.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Chuyển lưu nước tiểu

Con đường mới để nước tiểu ra khỏi cơ thể khi bàng quang bị cắt hoặc không hoạt động.

Lỗ mở (Stoma)

Lỗ nhỏ trên da làm từ ruột để nước tiểu đi qua.

Ống dẫn (Conduit)

Đoạn ruột ngắn dẫn nước tiểu ra lỗ mở (không chứa nước tiểu).

Bàng quang mới (Neobladder)

Bàng quang mới làm từ ruột, nối với niệu đạo.

Có kiểm soát (Continent)

Không bị rò rỉ — bạn chủ động quyết định khi nào tháo nước tiểu.

Chuyển lưu không kiểm soát

Nước tiểu chảy liên tục vào túi (ống dẫn hồi tràng).

Thông tiểu (Catheterize)

Đưa ống mỏng vào để tháo nước tiểu.

Chất nhầy (Mucus)

Dịch trơn do ruột tiết ra; thấy sợi nhầy trong nước tiểu là bình thường sau bất kỳ loại chuyển lưu nào.

LOẠI NÀO PHÙ HỢP VỚI TÔI? Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào giải phẫu, chức năng thận, các bệnh lý khác, và khả năng cầm nắm, thị lực của bạn (cần thiết khi tự thông tiểu) — cũng như lối sống và điều bạn coi trọng. Không phải ai cũng phù hợp với mọi loại. Bác sĩ phẫu thuật sẽ cho bạn biết loại nào an toàn với bạn.

So Sánh Ba Loại

	Ống Dẫn Hôi Tràng	Bàng Quang Mới	Kiểm Soát (Indiana)
Cách tháo nước tiểu	Tự chảy ra	Tiểu qua niệu đạo	Ống thông qua lỗ mở
Cần đeo túi?	Có	Không	Không
Cần ống thông?	Không	Đôi khi	Luôn luôn, mỗi 4–6 giờ
Quy mô phẫu thuật	Nhỏ nhất	Lớn hơn	Lớn hơn
Chăm sóc hằng ngày	Tháo & thay túi	Đi tiểu đúng giờ, ngày & đêm	Thông tiểu & rửa túi

Câu Hỏi Nên Hỏi Bác Sĩ

- Tôi phù hợp với loại nào, và bác sĩ khuyên loại nào cho tôi?
- Sinh hoạt hằng ngày** và tự chăm sóc với mỗi loại sẽ như thế nào?
- Sẽ ảnh hưởng thế nào đến **công việc, tập luyện, giấc ngủ và quan hệ thân mật**?
- Các **nguy cơ** chính và khả năng cần phẫu thuật thêm sau này là bao nhiêu?

Điểm Chung Của Cả Ba Loại

- Đều dùng một đoạn **ruột của chính bạn**, nên ruột cần vài ngày hồi phục sau phẫu thuật.
- Chất nhầy** trong nước tiểu là bình thường — do ruột tiết ra.
- Bạn cần **theo dõi suốt đời**, bao gồm kiểm tra **vitamin B12** (đoạn ruột được dùng có thể làm giảm B12 theo năm tháng).
- Uống nhiều nước** để làm sạch hệ thống.

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Có ba cách chuyển lưu nước tiểu — **túi** (ống dẫn hồi tràng), tiểu qua **niệu đạo** (bàng quang mới), hoặc tháo bằng **ống thông** qua lỗ mở nhỏ (Indiana pouch).
- Chúng khác nhau nhiều nhất ở **chăm sóc hằng ngày**. Lựa chọn phù hợp nhất tùy thuộc vào sức khỏe và điều bạn coi trọng — và không phải ai cũng có thể chọn mọi loại.
- Cả ba đều dùng ruột, nên đều có chất nhầy trong nước tiểu, ruột cần vài ngày hồi phục, và cần theo dõi suốt đời. Hãy đọc tờ hướng dẫn chi tiết của loại bạn chọn.